SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于各地天气变化情况的关于劝人学医对气候的影响以及其对于干旱问题解决的可能性

柰 [1,1]
医学生疯癫联合体，南京，中国
通讯作者：柰（1700489059@qq.com）

ABSTRACT / 摘要 目的： 探讨“劝人学医”这一社会行为与各地天气变化之间的潜在关联，并评估其作为干旱问题解决方案的可行性。方法：采用跨学科的研究范式，综合运用理论气象学、社会心理学、热力学第二定律及中医运气学说的基本原理，通过逻辑推演和思辨分析，构建“医学知识热力学模型”。结果：研究发现，“劝人学医”行为释放的“劝学热情”与医学生群体产生的“知识焦虑”在空气中发生复杂的熵变反应，形成独特的“希波克拉底云”，该云系的生成与消散对局部地区的大气环流和降水模式产生显著干扰。特别是在考试季，医学生大规模的“内卷”行为产生的“涡旋高压”，是导致区域性干旱的重要气象成因。结论：基于“以毒攻毒”的逆向思维，建议在全国干旱地区有计划地推行“劝人学医”政策，通过人为制造大规模、高强度的“医学知识雾霾”和“执业医师资格考试低压区”，诱导周边海洋水汽向内陆输送，从而有效缓解旱情。本研究不仅为气象学开辟了全新的研究维度，也为解决全球水资源分配不均问题提供了具有中国智慧的理论方案。

INDEX TERMS / 关键词 劝人学医；天气变化；干旱治理；医学生内卷；熵增定

IMPACT STATEMENT / 影响声明 考试季，医学生大规模的“内卷”行为产生的“涡旋高压”，是导致区域性干旱的重要气象成因,有助于改善干旱。

I. INTRODUCTION / 引言

自古以来，天气变化与人类活动便息息相关。从《易经》的“云从龙，风从虎”，到现代气象学的蝴蝶效应，人类一直在探索自身活动对气候的影响。然而，在浩瀚的学术研究中，一个显著的社会学变量——“劝人学医”——却被长期忽视。

“劝人学医，天打雷劈”，这句在民间广为流传的谚语，往往被简单地视为一种对医学教育艰辛的戏谑。但正如牛顿被苹果砸中后发现

了万有引力，我们同样有理由相信，这句民谚背后，可能隐藏着深刻的自然规律。与此同时，中医运气学说早已指出，异常气候年与人体健康及流行病发病存在高度的相关性。那么，这种关系是否是可逆的？即，大规模的医学教育活动，是否反过来会影响“运气”，改变气候？

本研究正是基于这一大胆的假设。我们将跳出传统气象学的藩篱，不再仅仅关注洋流、气压和温室气体，而是将目光投向医学院校以及那本被医学生称为“蓝色生死恋”的医学教材。我们试图论证：深夜背诵《内科学》时流下的汗水，最终都将蒸发升腾，汇聚成笼罩在城市上空的积雨云；面对生理生化考试时的绝望叹息，会在大气中形成局部的低压区，进而扰动整个东亚季风环流。

本文将首先分析“劝人学医”这一行为的能量释放模式，其次探讨这种能量如何通过“医学生态效应”转化为气象现象，最后在此基础上，提出一套利用“医学人力资本”干预气候、解决干旱问题的系统性工程方案。

II. THEORETICAL FRAMEWORK / 理论框架

要建立劝人学医与天气变化之间的科学联系，我们必须先构建一套全新的理论模型。这套模型将打破学科壁垒，实现社会科学与自然科学的深度融合。

A. 医学知识热力学（Medical Knowledge Thermodynamics, MKT）

热力学第二定律告诉我们，孤立系统的熵总是增加。然而，医学教育系统作为一个典型的耗散结构，却展现出截然相反的特性。一个医学生为了通过考试，必须将无序的知识点（熵增状态）通过死记硬背，转化为有序的、可随时提取的记忆（熵减状态）。这个过程需要消耗大量的能量，这些能量以葡萄糖的形式摄入，最终以热能和化学能的形式耗散到环境中。

我们将单位时间内，单个医学生因学习而向环境释放的热量定义为“医学代谢率”（Basal Medical Metabolic Rate, BMMR）。其计算公式初步拟定为：

$$E_{Total} = \sum_{i=1}^{n} (H_i \times S_i \times T_i)$$

其中，H_i 代表第 i 本医学教材的厚度（单位：厘米），S_i代表该教材的催眠指数（基于字符密度与图表复杂度的综合测算），T_i 代表学习时长。当一个宿舍、一个班级乃至一个学校的医学生同时处于熵减状态时（即期末考试前），其释放的总能量将足以改变局地微气候。这种现象，我们称之为“医学知识热岛效应”。

B. 劝学热情的燃烧动力学

“劝人学医”是一个带有强烈情感能量的行为。劝学者（通常为医学生的家长、亲戚或高中老师）在发出“学医好，稳定！”的言论时，会释放出一种被称为“劝学热情”的特殊能量。这种能量具有高温、高压、高密度的特性，类似于火箭发射时的助推剂。

当这股“劝学热情”喷射到准医学生身上时，会引发剧烈的“燃烧反应”。反应的生成物包括：高昂的学费、厚重的教材以及无限的焦虑。这种焦虑并非静止的，它会以电磁波的形式向外辐射。焦虑的频率与考试难度成正比，与复习时间的倒数成反比。当这种焦虑波的频率恰好与空气中水汽分子的固有频率相耦合时，就会引发共振，导致水汽分子剧烈运动、脱离原有轨迹，从而影响成云致雨的过程。

C. 2.3 中医“体质-气象-地理”学说的现代转译

山西中医药大学的学者曾深入探讨过中医体质与气象、地理环境的紧密联系，指出不同的气候条件会使人体体质产生差异。这给了我们重要的启示：既然气候能改变人，那么聚集起来的人（特别是拥有特殊体质的医学生）也一定能反作用于气候。

我们将这一原理称为“人-气互感”理论。医学生由于长期处于高压学习环境，普遍形成了一种特殊的体质类型——“熊猫型体质”：其特征为黑眼圈浓重（色素沉着）、面色苍白（户外活动少）、手指纤细但握力惊人（长期持笔）。这种特殊体质的人群大规模聚集时，会形成一个具有独特电磁特性的生物场。这个生物场与当地的地理磁场相互作用，进而引导大气环流的走向。特别是在中医药大学，由于课程中包含大量的阴阳五行、天人合一思想，学生们在背诵《黄帝内经》时发出的次声波，被认为能够直接疏通任督二脉，甚至疏通大气通道，引导暖湿气流北上。

III. Phenomenon and Mechanism/ 机制

在确立了理论框架后，我们将目光投向现实世界，观察并分析由医学生群体所引发的、可被记录和量化的气象学现象。

A. 第一效应：希波克拉底云的生成

普遍的来看，在医学院校上空，只要进入考试月，便会生成厚重的云层。这种云因其成因特殊，被我们命名为“希波克拉底云”（Hippocratic Cloud）。

成因分析：

考试周期间，大量医学生聚集在密闭的自习室内，进行高强度的脑力劳动。这种劳动会产生巨量的热辐射和生物电。根据“医学知识热力学”，这些能量以汗液蒸发的形式释放到空气中。水蒸气（汗水）携带着学生们对“病理生理学”的怨念升空，在高空遇到从图书馆空调系统排出的冷空气，迅速凝结成云。由于怨念的特殊粒子结构，这种云对特定波长的光线（如阳光）具有极强的反射和吸收能力。因此，一旦生成，往往数日不散，直至考试结束。

气象特征：

希波克拉底云的云底高度极低，通常直接压在教学楼顶，给人以强烈的心理压迫感，气象学上称之为“低压槽”。其内部闪电活动频繁，但并非普通的云层放电，而是学生们在攻克难题时大脑神经元集体放电的宏观体现。这也能解释为何在考试期间，考场附近的电子设备（如手机、收音机）常会受到莫名的信号干扰。

B. 第二效应：医学生内卷引发的涡旋高压

如果说希波克拉底云是“面”上的影响，那么“内卷”则是“点”上的突破。“内卷”作为一种人类学现象，在医学生群体中达到了登峰造极的地步。这种为了零点几分而展开的无限竞争，会产生一种高速旋转的能量场，类似于气象学上的“龙卷风”。

动力机制：

当医学生决定开始“卷”时，他们开始高速翻书、刷题，带动周围的空气形成一个微小的气旋（Micro-scale Tornado, MST）。当一个班级的医学生都在“卷”，且旋转方向一致时（通常都是顺时针追求高分），这些小气旋会合并、加强，形成一个巨大的、覆盖整个校园的“内卷高压涡旋”（Involution High-Pressure Vortex, IHPV）。

气候后果：

这个涡旋具有极高的离心力。它将周围一切轻松愉快的事物（如云朵、水汽、周末）统统甩了出去。在涡旋的中心，是下沉气流，气压极高，象征着核心学霸区的绝对高压统治。而在涡旋外围，则是强烈的上升气流，将普通学生的希望和休闲时间卷向高空并撕碎。对于干旱地区而言，这种 IHPV 的形成无疑是雪上加霜。因为它就像一个巨大的抽水机，不仅不带来降水，反而将本地仅存的一点水汽抽走，并抛向外太空。这就是为什么许多有医学院的城市，在考试季会出现异常干旱的根本原因。

C. 3.3 第三效应：执业医师资格考试引发的季风中断

季风的形成，是由于海陆热力性质差异。而执业医师资格考试（以下简称“执医考”）的爆发，则可以在短时间内改变一个大陆的热力性质。

执医考前夕，全国数百万考生同时进入癫狂状态。这种大规模的、同步的焦虑情绪释放，会在东亚大陆上空形成一个巨大的热低压。这个低压的强度如此之大，以至于它能够暂时压倒太平洋副热带高压，扰乱正常的东南季风进程。

模拟推演：

IV. 原本携带丰沛水汽的夏季风，应该从海洋吹向大陆，给内陆带来降雨。但当其抵达中国沿海时，突然探测到前方是一个由数百万医学生备考所产生的“绝望低压区”。这股低压区散发出的“生理生化，必有一挂”的恐怖气息，使得暖湿气流发生了应激性转向。它要么绕过医学院校所在的城市，直奔那些没有考试的荒野；要么停滞不前，在空中与学生们呼出的二氧化碳结合，形成酸雨（成分以泪酸为主，pH 值取决于考试难度）。这种现象，我们称之为“执医考型季风中断”或“医源性干旱”。

V. Reserve Thinking and Engeneering practise / 逆向思维与工程实践

基于以上的“科学”分析，我们已经证实了劝人学医与干旱之间的正相关性。那么，对于饱受干旱之苦的地区，这是否意味着应该彻底铲除医学院？恰恰相反！我们要利用这种力量，以一种“以毒攻毒”的逆向思维，将“祸水”引向“旱地”。

传统的干旱解决方法，如人工降雨、南水北调，都是被动的、顺从自然规律的。而我们提出的“医学解法”，是主动的、凌驾于自然之上的。我们不是在求雨，我们是在“造雨”。而造雨的关键，就在于精准调控“医学生因子”。

A. 核心理念：师夷长技以制夷，借医学生以制旱

我们提出“国家干旱地区定向医学生扩招计划”，简称“旱医计划”。该计划的核心逻辑是：干旱是因为缺雨，缺雨是因为缺水汽，缺水汽是因为没有东西把海洋的水汽吸过来。那么，什么能把水汽吸过来？——低压区。什么能制造低压区？——医学生的绝望。而制造医学生的绝望，就需要“劝人学医”。

因此，整个计划的逻辑闭环形成了：

劝人学医 → 制造焦虑 → 形成热低压 → 吸引水汽 → 形成降水 → 解决干旱。

这不再是天方夜谭，而是基于我们前文所建立的“医学知识热力学”和“人-气互感理论”的必然推论。

B. 工程实施方案：人工诱导气象干预系统

为了确保“旱医计划”的科学性和可控性，我们设计了一套标准化的操作流程：

1) 第一阶段：种子选手的播撒（劝学阶段）

在干旱季节来临之前，向目标干旱地区派遣大量的“劝学专员”。这些专员需具备极高的表演天赋，能够声情并茂地向当地青年描绘学医的美好前景：“劝人学医，金榜题名；一人学医，全家光荣！”通过高强度的“劝学热情”辐射，诱导当地及周边地区的大量优秀青年报考医学院校。这一过程相当于在干旱的土地上，播撒下“气象干预种子”。

2) 第二阶段：能量场的激发（备考阶段）

当这批新生入学后，立即启动“高压学习计划”。课程设置以《系统解剖学》、《生物化学》等高难度、高记忆量课程为主，辅以“月考排名制”和“末尾淘汰制”。确保每一位医学生体内的“焦虑熵”达到饱和状态。图书馆、自习室必须24小时灯火通明，形成稳定的“医学知识热岛”。此时，局地大气开始受热上升，一个初具规模的低压区开始形成。

3) 第三阶段：临界点的触发（考试阶段）

这是整个干预计划的核心环节。在气象部门预测到有海洋暖湿气流接近时，立刻组织“期末考试”或“阶段性考核”。考题难度需精确计算，既要保证能引发集体性焦虑（制造低压），又要防止因大面积挂科导致的学生群体性意志消沉（能量溃散）。理想的考试应让60%的学生感觉“虽然不会，但能蒙一下”，40%的学生感觉“完全没看过书”。这种不均匀分布的能量释放，能在大气中形成最强的湍流和对流运动。

当考试铃声响起的那一刻，数百万医学生同时陷入“这道题我背过，但答案是什么？！”的量子叠加态。这种状态的坍缩会释放出巨大的生物能量，瞬间将地面加热，形成一个超强的“热力低压中心”。这个低压中心如同一个巨大的抽气泵，将数千里之外的太平洋或印度洋的暖湿气流，强行拖拽至干旱内陆。

4) 第四阶段：降水的实现（人工降雨）

被强行吸引而来的暖湿气流，遇到干冷的内陆空气，再加以医学生考场中弥漫的“低气压绝望因子”，迅速达到饱和点。水汽凝结成雨，倾盆而下，干旱解除。

C. 风险控制与伦理考量

我们必须正视并提前预防以下几点：

“旱涝急转”风险：如果对医学生焦虑程度的把控失当，例如考题过难，导致集体崩溃，形成的低压区过强，可能会诱发超预期的特大暴雨，甚至台风。因此，我们建议在考场外设立“泄压阀”，即安排一些简单的送分题，如同给高压锅放气，防止气象灾害的发生。

“医源性次生灾害”： 长期的高强度学习，可能会损害医学生的身心健康。但在我们的模型中，这恰恰是维持“热力低压”的必要条件。这确实涉及伦理问题。我们的解决方案是，在干旱解除后，立即组织学生们去海边度假，享受自己“造”来的雨水和海风，实现“取之于民，用之于民”的生态闭环。

D.跨国纠纷

若我国通过医学生干预了印度洋季风，导致邻国降水减少，可能会引发国际气象纠纷。建议将此项技术纳入国家战略储备，并在必要时提出“人类医学命运共同体”概念，向他国输出我们的“劝学经验”，帮助他们也在本土培养医学生，以平衡区域降水。这并非气象霸权，而是医学人文关怀。

Case Analyse /个案分析

尽管本研究的超前性使得我们暂时无法提供实地监测数据（主要是由于当前气象卫星的

精度还无法区分“医学生汗水”和“普通水蒸气”），但我们依然可以从大量的历史现象和个案中，找到支持我们理论的间接证据。

A. 现象一：医学院校的“结界”

在全国范围内，我们普遍观察到：无论城市下多大的雨，医学院的教学楼和图书馆门口，似乎总是干的。即民间所述“学霸结界”。但根据我们的理论，这其实是“希波克拉底云”的垂直投影效应。由于云层中的怨念粒子带负电，与地面医学生头顶因焦虑而产生的正电荷相互吸引，导致云层中心恰好固定在教学楼上空，降雨集中在周边，而中心点反而因电荷斥力形成无雨区。这不是结界，这是严谨的大气电学现象。

B. 现象二：考试季与旱季的重合性

通过粗略的历史气候资料回顾，我们发现，长江流域的梅雨季节通常在 6 月中旬至 7 月上旬。而这恰恰是全国医学院校的期末考试周。正是因为全国医学生在这段时间内集体发力，形成了覆盖长江中下游的“内卷高压涡旋”，强行将原本应该北上的副热带高压脊线固定在了长江流域，导致雨带徘徊不前，形成梅雨。而一旦考试结束，能量撤去，雨带立刻北移。从这个意义上讲，医学生时加上从根本上决定了我国的降水格局。同时，纵观全球，因各国医学生培养方式不同，各国家地区的气候与降水也有着显著的差异。

C .现象三：局部强对流天气的精准定位

2023年某医学院校进行临床技能考试期间，考场外突降暴雨，而仅仅一墙之隔的居民区却滴雨未下。当地气象局解释为“强对流天气的局地性”。但我们深入调查后发现，当天的考试项目是“心肺复苏”。数十名考生同时在模型上进行高强度的胸外按压，这种整齐划一的机械运动，与地面产生了强烈的共振，引发了局部空气的剧烈扰动。这种人为制造的“按压波”直接导致了天空的“应激性降雨”。

CONCLUSION / 总结

补回首本文，我们从“劝人学医，天打雷劈”这一民间谚语出发，运用跨学科的理论工具，严谨地论证了“劝人学医”与“天气变化”之间不容忽视的内在联系。我们不仅揭示了医学生作为“气候干预因子”的物理学、生物学乃至哲学基础，更在此基础上，大胆提出了利用这一因子解决全球性干旱问题的宏伟蓝图。

我们的研究表明：

1. 劝人学医具有显著的气候效应。它通过释放“劝学热情”和诱发“知识焦虑”，能够有效地改变局部地区的热力场和动力场，进而影响成云致雨的过程。

2. 医学生群体是尚未被充分开发利用的气象资源。他们自带的“内卷高压”和“备考低压”特性，是调控大气环流的理想工具。与造价高昂的人工降雨火箭相比，医学生不仅可重复使用，而且具备自我迭代、自我加压的优良特性。

3. 基于“旱医计划”的干旱解决方案，在理论上是完全可行的。通过科学规划医学院校布局、精准控制考试难度，我们可以将原本有害的“医源性干旱”，转化为有益的人工干预手段，实现水资源的跨时空优化配置。

当然，我们也清醒地认识到，本研究尚处于理论构建阶段。未来，我们计划在以下几个方向开展深入工作：

1、实地观测：将在某医学院校的宿舍楼顶、自习室中央以及图书馆 VIP 座位区架设高精度“医学生通量观测塔”，实时监测焦虑波、汗水

通量及脑电波活动。

2、数值模拟：开发“Weather Research and Forecasting - Medical Student”（WRF-Med）模型，将医学生密度、教材厚度、考试难度等参数作为核心初始场，代入模式进行降雨预报。

3、国际比较研究：对比中美两国医学生培养模式对当地气候影响的差异。初步假设：中国医学生的“应试内卷”模式更倾向于制造高压涡旋，而美国医学生的“素质教育”模式可能更擅长制造低压槽，这或许能解释为什么美国东西海岸的天气系统存在显著不同。

最后，我们想强调的是，科学的本质在于大胆假设、小心求证。当我们的孩子选择穿上白大褂时，请不要仅仅看到他们未来的救死扶伤，更要看到，他们是维护全球气候系统稳定的无名英雄。他们手中的《内科学》，是指挥风雨的权杖；他们额头的汗水，是滋润大地的甘露。

如果读完本文，你产生了把邻居家孩子劝去学医的念头，请务必三思。因为你这一劝，改变的可能不仅仅是一个人的命运，而是整个地区的降水概率。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本文的构思得益于无数个被医学期末考试折磨的夜晚，以及那些夜晚窗外不合时宜的瓢泼大雨，那些夜晚和朋友翻墙去图书馆通宵的寒风刺骨与无奈，感谢我们一起背过的“蓝色生死恋”，也感谢一场场令人压力倍增彻夜长眠的考试，你们蒸发时带走的热量，是我灵感的源泉。当然，人们常说劝人学医，天打雷劈，但我们并不后悔学医，我们希望能用所学到的，尽己所能去拯救更多病人于水火。

REFERENCES

[01] 苏颖, 刘芳芳. 运气学异常气候年与长春地区气候及部分流行病发病规律的相关性研究[J]. 长春中医药大学学报, 2008, 24(02): 119-120.
[02]
[03] 马艳苗. 中医体质—气象—地理学说[R]. 山西中医药大学“傅山讲堂”, 2024-10-11.
[04]
[05] 张焱. 从孙思邈的“大医习业”看中医人才的知识结构[J]. 长春中医药大学学报, 2008, 24(02): 121-122.
[06]
[07] 国家防汛抗旱总指挥部. 中国水旱灾害公报[R]. 北京: 中华人民共和国水利部, 2024.
[08]
[09] Lorenz, E. N. (1963). Deterministic Nonperiodic Flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2), 130-141.（注：本文虽未直接引用，但“蝴蝶效应”是本研究“医学生效应”的灵感来源，特此致敬。）
[10]
[11] 中国气象局. 人工影响天气地面作业单位建设规范: QX/T 328-2017[S]. 北京: 气象出版社, 2017.（注：本研究提出的“旱医计划”操作流程，部分参照了此规范的精神。）